

Trauma torácico · pneumotórax e ameaças

No trauma torácico, as ameaças imediatas ao B são pneumotórax hipertensivo, aberto e tórax instável/contusão. Diagnóstico clínico no instável — não atrase descompressão por Rx.

PNT simples

Dica - PNT simples

Pode ser olhido no primário se estável. Confirme com Rx/USG (e-FAST) e drene conforme tamanho/sintoma/ ventilação mecânica — PNT + VPM tem alto risco de hipertensão.

Triagem ATLS: hipertensivo !' agulha/dreno; aberto !' curativo 3 pontas + dreno; hemotórax massivo !' dreno + sangue/cirurgia.

Ameaças torácicas ao B

Hipertensivo / aberto / hemotorax massivo

PNT hipertensivo

Distress + desvio traqueal
MV abolido / turgencia
Descompressao imediata

Emergencia clinica

PNT aberto

Ferida sugadora
Curativo 3 pontas
Toracostomia

Nao ocluir 4 lados

Hemotorax massivo

>1500 mL ou debito alto
Dreno + reanimacao
Toracotomia se indicado

Choque + torax

Pontos de prova

- Descompressão: agulha no 2º EIC linha hemiclavicular ou 5º EIC axilar anterior, seguida de dreno
- Dreno torácico: 4º/5º EIC linha axilar média (triângulo de segurança)
- Tórax instável: O., analgesia, VPM se insuficiência; fixação cirúrgica selecionada
- Tamponamento: choque + jugulares + bulhas abafadas !' pericardiocentese/janela

Achados clínicos

Lesão | Clínica-chave

PNT hipertensivo | Hipotensão + MV! + desvio contralateral

PNT aberto | Ferida torácica com bolhas/som

Hemotórax | Macicez + choque + MV! +

Contusão pulmonar | Hipoxemia progressiva pós-trauma

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Pneumotórax hipertensivo é diagnóstico clínico. Não leve o instável ao Rx 'para confirmar' antes de descomprimir.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Trauma torácico ATLS: lethal six no exame primário e hidden six no secundário — padrão clássico de prova.

As seis lesões que matam rápido — trate no ABCDE, muitas vezes clinicamente.

Lethal six

Ameaças do exame primário

- 1 Obstrução de via aérea
- 2 Pneumotorax hipertensivo
- 3 Pneumotorax aberto
- 4 Hemotorax massivo
- 5 Torax instável (flail chest)
- 6 Tamponamento cardíaco

Primário = lethal six

Podem passar despercebidas no primário — busque no secundário e com imagem.

Hidden six

Ameaças do exame secundário

- 1 Ruptura aórtica / grande vaso
- 2 Contusão miocárdica
- 3 Contusão pulmonar
- 4 Ruptura diafragmática
- 5 Ruptura traqueobronquial
- 6 Ruptura esofágica

Secundário = hidden six

Condutas salva-vidas (B/C)

Lesão | Conduta clássica

PNT hipertensivo | Descompressão imediata + dreno

PNT aberto | Curativo de 3 pontas + toracostomia

Hemotórax massivo | Dreno; sangue; toracotomia se critério

Tamponamento | FAST; pericardiocentese/janela; cirurgia

Hemotórax — indicação cirúrgica (ideia)

Dica - Hemotórax — indicação cirúrgica (ideia)

Drenagem inicial ~"e1500 mL ou débito alto persistente (ex.: "e200 mL/h por 2–4 h) + instabilidade !'
pensar toracotomia (valores de protocolo local).

Lembretes

- Flail: oxigenação, analgesia multimodal, VNI/IOT se falência
- Contusão pulmonar: piora em horas — evite sobrecarga hídrica
- Diafragma: Rx com NGT 'no tórax'; TC/cirurgia conforme lado/estabilidade

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1